CORPS ET HORMONES

Testostérone et âge : ce qui baisse vraiment, et ce que le sport peut faire

On parle beaucoup d'andropause et de baisse de testostérone, souvent pour vendre des compléments. Que se passe-t-il vraiment avec l'âge chez les hommes, et quel rôle joue l'entraînement ? Les faits, sans marketing.



SANTÉ

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

Cet article s'adresse surtout aux hommes. Il peut aussi intéresser leur entourage.

01

La testostérone, à quoi ça sert ?

La testostérone est la principale hormone sexuelle masculine. Elle est produite surtout par les testicules, et en plus petite quantité chez les femmes par les ovaires et les glandes surrénales. Chez l'homme, elle intervient dans le développement et le maintien de la masse musculaire et osseuse, la répartition des graisses, la production de globules rouges, la libido, l'humeur et l'énergie.

02

Ce qui se passe avec l'âge

Contrairement à la ménopause chez la femme, il n'y a pas chez l'homme d'arrêt brutal de la production hormonale. Le terme d'andropause est donc trompeur. Ce qu'on observe, c'est une baisse progressive et très variable d'un homme à l'autre.



Une baisse lente au fil des années

Selon les grandes études de cohorte, la baisse est en général estimée entre moins de 1 % et environ 2 % par an après 40 ans, avec de fortes différences d'un homme à l'autre. La Massachusetts Male Aging Study, qui a suivi des hommes américains pendant plusieurs années, a beaucoup contribué à ces connaissances. Une analyse de cette cohorte publiée en 2007 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a même observé une baisse des taux d'une génération à l'autre, à âge égal.

De nombreux travaux montrent aussi que l'état de santé et le mode de vie comptent. L'obésité, les maladies chroniques, le manque de sommeil et la sédentarité sont associés à des taux plus bas. Autrement dit, l'âge n'explique pas tout.

> **L'âge fait baisser doucement la testostérone, mais le mode de vie pèse lourd dans la balance.**

03

Quand faut-il s'inquiéter ?

Une baisse modérée liée à l'âge est normale. Un vrai déficit, en revanche, se diagnostique par un médecin, à partir de symptômes et de prises de sang répétées, le matin. Les signes qui peuvent faire évoquer un déficit sont notamment une baisse marquée de la libido, des troubles de l'érection, une fatigue persistante, une perte de masse musculaire, une humeur dépressive.

Ces symptômes ont souvent d'autres causes, d'où l'importance d'un bilan médical plutôt que de l'automédication. Les compléments vendus en ligne pour booster la testostérone n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, et certains produits peuvent être dangereux.

04

Ce que le sport peut faire

L'entraînement n'est pas un traitement hormonal, mais il agit sur la plupart des conséquences de la baisse de testostérone, et sur certains des facteurs qui la favorisent.

- Le renforcement musculaire maintient et développe la masse et la force musculaire, quel que soit l'âge. C'est la meilleure réponse à la perte musculaire progressive.
- L'activité physique aide à réduire la graisse abdominale, elle-même associée à des taux de testostérone plus bas.
- Elle améliore la sensibilité à l'insuline et la santé cardiovasculaire.
- Elle améliore souvent la qualité du sommeil, un facteur important de l'équilibre hormonal.
- Elle a un effet favorable sur l'humeur et le stress.

Les séances de musculation qui sollicitent de grands groupes musculaires provoquent des hausses temporaires de testostérone. Mais l'intérêt principal de l'entraînement n'est pas ce pic passager : c'est l'effet sur le muscle, l'os, la graisse abdominale et la santé globale.

05

Attention au surentraînement

À l'inverse, un entraînement d'endurance très volumineux, sans récupération suffisante et avec des apports énergétiques trop faibles, peut faire baisser la testostérone. C'est ce qu'on observe chez certains sportifs d'endurance de haut niveau. L'équilibre entre charge d'entraînement, alimentation et repos est donc essentiel.

> **Le bon cocktail : du renforcement régulier, de l'endurance, assez de sommeil et assez à manger.**

06

Les autres leviers

- Le sommeil : dormir au moins 7 heures. La production de testostérone suit un rythme lié au sommeil.
- Le poids : réduire un excès de graisse abdominale, par l'alimentation et l'activité physique.
- L'alcool : le limiter. Les repères français sont de maximum 2 verres par jour, pas tous les jours.
- Le stress : un stress chronique pèse sur l'équilibre hormonal.
- L'alimentation : suffisamment d'énergie, de protéines et de bonnes graisses, des fruits et légumes.

07

Ce que je te propose

- Deux à trois séances de renforcement par semaine, avec des exercices polyarticulaires et une progression régulière.
- De l'endurance, pour le cœur et la composition corporelle.
- Une attention particulière à la récupération et au sommeil.
- Un suivi de tes progrès dans l'appli, pour voir concrètement ta force augmenter.

Si tu as des symptômes qui t'inquiètent, parles-en d'abord à ton médecin. Je m'adapte ensuite à ses recommandations.

À RETENIR

- Chez l'homme, il n'y a pas d'arrêt brutal mais une baisse progressive et variable de la testostérone.
- Le mode de vie, le poids, le sommeil et les maladies chroniques comptent autant que l'âge.
- Un vrai déficit se diagnostique chez le médecin, pas avec des compléments.
- Le renforcement musculaire est la meilleure réponse à la perte musculaire liée à l'âge.
- Attention au surentraînement et aux apports insuffisants, qui peuvent faire baisser la testostérone.

SOURCES

- Travison T.G. et al., A population-level decline in serum testosterone levels in American men, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2007) : https://doi.org/10.1210/jc.2006-1375
- Santé publique France, Comment réduire les risques de la consommation d'alcool : https://www.santepubliquefrance.fr/alcool/comment-reduire-les-risques-de-la-consommation-dalcool
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886
- Watson N.F. et al., Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult, Journal of Clinical Sleep Medicine (2015) : https://doi.org/10.5664/jcsm.4758